

CAPÍTULO 13.11

Manejo de contactos de coqueluche

PERFIL EUNACOM 5.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de los contactos de un paciente con **Coqueluche** (producido por *Bordetella pertussis*) es fundamental para controlar los brotes y proteger a las poblaciones vulnerables. El objetivo principal de la quimioprofilaxis es reducir la transmisión y, en casos específicos, atenuar la gravedad de la enfermedad.

Quimioprofilaxis Antibiótica

El fármaco de elección para el manejo de contactos es la **Azitromicina**.

- **Esquema:** Se administra por **5 días**.
- **Dosis:** Es exactamente la misma dosis utilizada para el tratamiento de la enfermedad activa.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En EUNACOM, recuerda que la **Azitromicina por 5 días** es la respuesta estándar tanto para el tratamiento del caso índice como para la profilaxis de los contactos.

¿A quiénes se debe tratar?

La decisión de iniciar antibióticos en contactos depende de la presencia de síntomas y de los factores de riesgo del individuo.

1. Contactos Sintomáticos

Se debe tratar a **todo contacto que presente síntomas**, sin importar su edad o antecedentes. Esto incluye pacientes en: - **Fase catarral:** (ej. solo rinorrea). Es el momento de mayor contagiosidad y donde el antibiótico tiene mayor impacto. - **Fase paroxística:** (fase de la tos).

NOTA CLÍNICA

El tratamiento en contactos sintomáticos es la única intervención con evidencia sólida que respalda la **disminución de la duración y severidad de los síntomas**.

2. Contactos Asintomáticos

La evidencia científica no respalda el uso indiscriminado de antibióticos en todos los contactos asintomáticos. Sin embargo, las recomendaciones internacionales y nacionales indican tratarlos si presentan **factores de riesgo de enfermedad grave** o si pueden transmitir la bacteria a personas vulnerables.

Grupos de Riesgo para Profilaxis (Asintomáticos):

TABLA 13.11.1: GRUPO DE RIESGO VS JUSTIFICACIÓN CLÍNICA

GRUPO DE RIESGO	JUSTIFICACIÓN CLÍNICA
Menores de 1 año	Tienen el mayor riesgo de complicaciones graves y muerte.
Menores de 2 años con esquema incompleto	Aquellos con menos de 3 dosis de la vacuna (2, 4 y 6 meses).
Mayores de 65 años	Riesgo de descompensación por fragilidad o comorbilidades.
Embarazadas en 3er trimestre	El objetivo es evitar que la madre contagie al recién nacido al nacer.
Pacientes Hospitalizados	Para evitar brotes intrahospitalarios y proteger a otros pacientes graves.
Enfermedades Crónicas	Patologías que se descompensan con la tos (Pulmonares, Cardíacas, Epilepsia).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes con **Epilepsia**, el coqueluche es especialmente peligroso debido al riesgo de gatillar crisis convulsivas por la hipoxia o el esfuerzo tusígeno.

Inmunización y Bloqueo

Además de la profilaxis antibiótica, se debe revisar el estado vacunal de todos los contactos según el **Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI)**.

- **Acelerar el esquema:** Si un niño tiene dosis pendientes, se deben administrar de inmediato.
- **Esquema habitual en Chile:**
 - 1ra dosis: 2 meses.
 - 2da dosis: 4 meses.
 - 3ra dosis: 6 meses.
 - 4ta dosis (Refuerzo): 18 meses.
 - Refuerzos escolares (1º y 8º básico).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un contacto tiene el esquema incompleto (por ejemplo, se saltó la dosis de los 18 meses), la conducta correcta es **completar el esquema de inmediato**.

Resumen de Factores que Obligan a Profilaxis

- Menores de 1 año. - Esquema de vacunación incompleto. - Mayores de 65 años. - Embarazo (3er trimestre). - Pacientes con riesgo de descompensación: - **Pulmonares:** Riesgo de insuficiencia respiratoria. - **Cardíacos:** Riesgo de congestión pulmonar. - **Epilépticos:** Riesgo de convulsiones. Para más detalles sobre la presentación clínica, ver el artículo de **Coqueluche: Generalidades**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de 8 meses, contacto de un hermano con coqueluche confirmado, se encuentra asintomático y tiene solo 2 dosis de vacuna antipertussis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de contactos de coqueluche. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La profilaxis de contactos de coqueluche se realiza con azitromicina por 5 días, misma dosis que el tratamiento
- Los contactos sintomáticos (fase catarral o de tos) deben recibir antibiótico obligatoriamente
- En contactos asintomáticos sin factores de riesgo, la evidencia no respalda el uso de antibióticos
- Factores de riesgo para indicar profilaxis en asintomáticos: menores de 1 año, menores de 2 años sin esquema vacunal completo, mayores de 65 años
- Embarazadas en tercer trimestre deben recibir profilaxis para evitar contagio al recién nacido
- Pacientes con enfermedades pulmonares, cardíacas o epilepsia son de riesgo por descompensación
- Pacientes hospitalizados deben recibir profilaxis para evitar contagio intrahospitalario
- Ante un contacto, se debe acelerar y completar el esquema de vacunación si está incompleto

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE CONTACTOS DE COQUELUCHE)**PREGUNTA 1**

Un niño de 8 meses, contacto de un hermano con coqueluche confirmado, se encuentra asintomático y tiene solo 2 dosis de vacuna antipertussis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Observar y controlar en 48 horas
- B)** Indicar azitromicina por 5 días y completar esquema de vacunación
- C)** Indicar azitromicina por 10 días
- D)** Indicar amoxicilina por 7 días
- E)** No requiere manejo, solo completar vacunación

PREGUNTA 2

¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada la profilaxis antibiótica en un contacto asintomático de coqueluche?

- A)** Adulto de 30 años sano con esquema de vacunación completo
- B)** Niño de 5 años con esquema de vacunación completo
- C)** Embarazada de 34 semanas de gestación
- D)** Adolescente de 15 años sano
- E)** Adulto de 40 años sin comorbilidades

PREGUNTA 3

Respecto al manejo de contactos de coqueluche, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A)** La profilaxis antibiótica está indicada en todos los contactos independientemente de los síntomas
- B)** La azitromicina profiláctica se indica por 10 días
- C)** Los contactos sintomáticos deben recibir azitromicina por 5 días para disminuir la duración de los síntomas
- D)** No es necesario modificar el esquema de vacunación ante un brote
- E)** La profilaxis solo se indica en contactos menores de 6 meses

RESUMEN: MANEJO DE CONTACTOS DE COQUELUCHE

El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. La evidencia científica indica que el antibiótico debe indicarse a los contactos sintomáticos, ya sea que estén en fase catarral o en fase de tos, ya que es lo único respaldado para disminuir la duración de los síntomas. En el caso de los contactos asintomáticos, la evidencia no respalda el uso de antibióticos de forma rutinaria. Sin embargo, las recomendaciones internacionales sugieren indicar profilaxis antibiótica si el contacto presenta factores de riesgo: menores de un año, menores de dos años sin al menos tres dosis de vacuna, mayores de 65 años, pacientes hospitalizados, embarazadas en el tercer trimestre, y personas con enfermedades que puedan descompensarse por la tos (pulmonares, cardíacas, epilepsia). Respecto a la vacunación, cuando existe un contacto se debe acelerar y completar el esquema de vacunación del Plan Nacional de Inmunizaciones, especialmente si está incompleto. Si se saltó alguna dosis, debe administrarse de inmediato.